



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Health Guide PL

Getting public healthcare in Poland

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>



Текст:

lek. med. Justyna Laskowska

lek. med. Iwona Walczyk - Czapla

Adam Laskowski

Переклад:

Kyrylo Shafarenko

Видання:

Nina Potiienko

Jacek Czopek

Зміст

Абревіатури:	6
I. Державна медична допомога.....	7
1. Як виглядає структура охорони здоров'я в Польщі?	7
2. Чи маю я право на безкоштовне медичне обслуговування?	7
3. Як я можу застрахуватись?	8
4. Чи я можу застрахувати чоловіка/дружину та дітей?	8
5. Як вибрати свого лікаря POZ та поліклініку?	8
II. Первинна медико-санітарна допомога (POZ)	9
1. Хто такий лікар POZ?	9
2. Чим займається лікар POZ?	9
3. Як записатися до лікаря POZ?	10
4. Які документи потрібні на візит до лікаря POZ?	10
5. Чи завжди консультація лікаря POZ відбувається в поліклініці?	11
6. Чи можу я відвідати заклад POZ зі своєю дитиною?	11
7. Хто така медична сестра POZ?	12
8. Хто така акушерка POZ?	12
9. В яких годинах працює заклад POZ?	13
III. Обліковий запис пацієнта	13
1. Що таке обліковий запис пацієнта (IKP)?	13
2. Як увійти в IKP і заповнити декларацію до POZ?	14
IV. Рецепт на ліки	16
1. Що таке рецепт?	16
2. На які ліки потрібен рецепт?	16
3. На які ліки не потрібно мати рецепт?	16
4. Як отримати рецепт?	16
5. Що робити, коли я отримав рецепт?	17
6. Як купити ліки зі знижкою?	17
7. Чи може закінчитися термін дії електронного рецепта	17
V. Лікарняні	18
1. Що таке електронний листок непрацездатності (eZLA)?	18
2. Як довго я можу перебувати на лікарняним?	18
3. Що робити, якщо я досі залишаюся хворий, але не маю права на лікарняне?	19
4. Чи маю я право на лікарняне, якщо моя дитина чи інший член сім'ї хворіє?	19
5. Чи заробітна плата на лікарняному однакова як під час працездатності?	19
6. Чи роботодавець дізнається про мій діагноз?	20
7. Чи можу я отримати лікарняне з минулою датою або ж наперед?	21
8. Чи потрібно мені робити медичне обстеження, перш ніж повернутися на роботу?	21
VI. Первинна медико-санітарна допомога – діти.	22
1. На яку медичну допомогу може розраховувати моя дитина в POZ?	22
2. Що таке профілактичний огляд дитини (баланс здоров'я дитини)?	22
3. Як вакцинувати дитину?	23
4. Що таке календар вакцинації?	23

5. Як відбуватиметься вакцинування моєї дитини?	24
6. Де можна придбати вакцину?	24
7. Які щеплення являються обов'язковими для дітей в Польщі?	25
VII. Організація профілактичних щеплень	26
1. Де можна зробити щеплення?	26
2. Де можна зробити щеплення для моєї дитини?	26
3. Які щеплення мені слід доповнити?	26
VIII. Нічна та святкова медична допомога	27
1. Що таке нічна та святкова медична допомога?	27
2. В яких годинах працює заклад нічної та святкової медичної допомоги?	27
3. Де знайти адреси нічних та святкових закладів медичної допомоги?	27
4. З якими проблемами потрібно звертатися до нічних та святкових закладів медичної допомоги?	28
IX. Відділення екстреної допомоги (SOR)	28
1. Що таке SOR?	28
2. Як довго я буду чекати на лікаря в SOR?	28
3. В яких ситуаціях я можу звернутися до SOR?	29
4. В яких ситуаціях не можна звертатися до SOR?	29
5. Які документи потрібно взяти з собою до SOR?	30
X. Служба швидкої допомоги	30
1. Що таке швидка медична допомога?	30
2. В яких ситуаціях я маю викликати швидку допомогу?	30
3. Як викликати швидку допомогу?	31
4. Чи бригада швидкої допомоги відвезе мене у лікарню?	31
XI. Амбулаторна спеціалізована медична допомога (AOS)	31
1. В яких ситуаціях мені варто записатися до спеціалізованої амбулаторії. ..	31
2. Як записатися до спеціалізованої амбулаторії?	32
3. Чи потрібне мені направлення до кожної спеціалізованої амбулаторії?	32
4. Як довго потрібно чекати на візит до лікаря-спеціаліста?	32
XII. Перебування на стаціонарному лікуванні	33
1. Хто може направити мене на стаціонарне лікування?	33
2. Чи повинен я погоджуватися на запропоноване лікування в стаціонарі? ..	33
3. Які права має пацієнт?	33
4. Чи зобов'язана лікарня надати іноземному хворому перекладача?	34
XIII. Вагітність та пологи	35
1. Хто може вести вагітність?	35
2. Якщо я вагітна, коли мені потрібно стати на облік і чи потрібне направлення?	35
3. На чому полягає медичний облік вагітної?	35
4. Чи я маю право на УЗД під час вагітності?	35
5. Що таке пренатальний скрінінг?	36
6. Чи я можу працювати під час вагітності?	36
7. Якщо я вагітна, чи може роботодавець через це мене звільнити?	37
8. Чи мають вагітні особливі права?	37
9. Акушерка POZ.	37
10. Де жінки народжують дітей в Польщі?	38

11. Що робити, якщо після повернення додому у мене виникли проблеми з грудним вигодовуванням?.....	38
12. Які адміністративні справи я мушу вирішити після народження дитини? .	38
13. Скільки триває декретна відпустка по вагітності і пологах?	39
14. Чи повинна я використати всю декретну відпустку по вагітності і пологах?	39
15. Що таке декретна відпустка по догляду за дитиною?	40
16. Чи зміниться моя зарплата під час декретної відпустки?	41
17. Що таке декретна відпустка по вихованню дитини?	41
XIV. Стоматологічна допомога	42
1. Чи потрібно мати направлення до стоматолога?	42
2. Чому поляки обирають приватну стоматологічну допомогу?	42
3. Що робити під час гострого зубного болю?	42
XV. Медична реабілітація	43
1. Які захворювання вимагають реабілітації?	43
2. Як виглядає реабілітаційне лікування?	43
3. Що таке соціальна допомога на реабілітацію?	44
XVI. Санаторно-курортне лікування	44
1. Що таке санаторно-курортне лікування?	44
2. Чи потрібне направлення на санаторно-курортне лікування?	45
3. Що робити після отримання направлення?	45
4. Скільки триває санаторно-курортне лікування?	45
XVII. Лікування залежності	46
1. Що робити, якщо я підозрюю у себе залежність?	46
2. Як виглядає лікування залежності?	47
3. Де я можу знайти інформацію про лікування алкогольної залежності?	47
4. Що таке клуб AA?	47
XVIII. Онкологія	48
1. Що робити, якщо я підозрюю у себе онкологічне захворювання?	48
2. Що таке карта DiLO?	48
3. Чи покриває страхування паліативну та хоспісну допомогу?	48
XIX. Медичні вироби	49
1. Що таке медичні вироби?	49
2. Чи покриває страхування закупівлю медичних виробів?	49
3. Як отримати дозвіл на закупівлю медичного виробу?	49
4. Де можна купити медичні вироби?	49
XX. Довірений профіль	50
1. Що таке довірений профіль?	50
2. Як створити довірений профіль?	50
XXI. Словник термінів	50
XXII. Бланки декларацій про вибір лікаря, медсестри та акушерки POZ	55
Ім'я і прізвище акушерки первинної ланки	61
XXIII. Умови проведення патронажів та планових обстежень дитини, в тому числі скрінінгові дослідження	63

Абревіатури:

AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna → Амбулаторна спеціалізована медична допомога

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej → Електронна Платформа Державних Адміністративних Послуг

eZLA - elektroniczne Zwolnienie Lekarskie → Електронний листок непрацездатності (е-лікарняний)

IKP - Internetowe Konto Pacjenta → Обліковий запис пацієнта

Karta DiLO - Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego → Карта діагностики та онкологічного лікування

klub AA - klub Anonimowych Alkoholików → спільнота Анонімних Алкоголіків

KOC - Koordynowana Opieka nad Kobieta w ciąży → Координований догляд за вагітними жінками

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia → Національний Фонд Охорони Здоров'я

POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna → Первинна медико-санітарна допомога

PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych → Платформа електронних послуг закладу соціального страхування

SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy → Відділення невідкладної медичної допомоги

USC- Urząd Stanu Cywilnego → Орган реєстрації актів цивільного стану (РАЦС)

I. допомога

Державна медична

1. Як виглядає структура охорони здоров'я в Польщі?

У Польщі існують державна медична допомога, доступна кожній застрахованій особі, яка фінансується з державного бюджету та платна медична допомога. В нашій публікації ми зосередимося на державній охороні здоров'я.

Деякі заклади надають як платні, так і безкоштовні медичні послуги. Пам'ятай, записуючись до лікаря на візит, переконайся, що ця послуга підлягає під договір медичного закладу з Національним Фондом Здоров'я (NFZ) – тобто являється безкоштовною.

2. Чи маю я право на безкоштовне медичне обслуговування?

Так. Кожна людина, яка працює в Польщі, підлягає обов'язковому медичному страхуванню. Метою медичного страхування є захист здоров'я людини. У рамках програми страхування кожен має право на безкоштовне лікування, діагностику, медсестринську допомогу, реабілітацію, перебування в стаціонарі, санаторно-курортне та профілактичне лікування. Якщо ви застраховані в Польщі, ви маєте такий самий доступ до медичної допомоги, як і застраховані громадяни Польщі.

3. Як я можу застрахуватись?

Якщо ви працюєте на підставі трудового договору або цивільно-правового договору про надання послуг, роботодавець самотійно подає заявку на отримання вами медичного страхування у Заклад соціального страхування (ZUS), а страхові внески покриваються з вашої заробітної плати. Якщо ви ведете власний бізнес, ви повинні самотійно подати заявку на страхування в ZUS. Грошові внески з ZUS перераховуються до NFZ. Це державний організаційний підрозділ, який займається фінансуванням медичних послуг.

4. Чи я можу застрахувати чоловіка/дружину та дітей?

До медичного страхування впишіть всіх непрацюючих членів сім'ї, які проживають з вами – вашого чоловіка, дружину, дитину, батьків, бабусю чи дідуся. Заявка на страхування для членів сім'ї є безкоштовною та необмеженою (тобто ви можете подати заявку на страхування скільки завгодно членів сім'ї).

5. Як вибрати свого лікаря POZ та поліклініку?

Ви можете вибрати будь-який заклад Первинної медико-санітарної допомоги (POZ) у своєму воєводстві.

Найзручніше, якщо об'єкт буде розташований поруч із

вашим будинком. Вам слід відвідати обрану поліклініку (т. зв. заклад POZ) та заповнити декларацію про вибір лікаря, медсестри та акушерки (для жінок).

Форми декларації ви знайдете в кінці публікації.

Декларації також можна подати через ваш Обліковий запис пацієнта (IKP). Ви можете змінювати свого лікаря POZ двічі на рік безкоштовно.

Перелік закладів POZ можна знайти на сайті NFZ:

<https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/>.

II. Первинна медико-санітарна допомога (POZ)

1. Хто такий лікар POZ?

Лікар POZ (лікар первинної ланки) займається лікуванням дорослих (терапевт, тобто спеціаліст з внутрішніх хвороб, або сімейний лікар) та дітей (педіатр, тобто спеціаліст з дитячих хвороб, або сімейний лікар).

2. Чим займається лікар POZ?

Лікар POZ керує всім процесом лікування. В його компетенції входить:

- Лікування хворих та надання консультацій.
- Призначення лікарських засобів та контроль перебігу медикаментозного лікування.
- Видача рецептів на ліки та медичні товари.
- Оформлення лікарняних.

- Направлення на обов'язкові щеплення та періодичні медичні огляди.
- Направлення на дослідження, наприклад, на лабораторні аналізи, ЕКГ, рентген, УЗД.
- Інтерпретація результатів дослідження.
- Направлення на санаторно-курортне та реабілітаційне лікування.
- Направлення до лікарів-спеціалістів та лікарень.
- Направлення на довгострокову допомогу патронажної медичної сестри.
- Виставлення довідки про стан здоров'я пацієнта.
- Видача направлення на послуги медичної сестри POZ.

3. **Як записатися до лікаря POZ?**

Найчастіше дата приймання до лікаря встановлюється по телефону, в особливих випадках візит відбувається в день реєстрації, в інших випадках займає в середньому 3 - 5 днів.

4. **Які документи потрібні на візит до лікаря POZ?**

Завжди беріть із собою посвідчення особи з фотографією та номером PESEL, а у разі дитини додатково медичну книжку. Під час першого відвідування візьміть повну медичну документацію про лікування та перелік ліків, які ви приймаєте. Якщо це наступний візит, візьміть

rezultaty analizów albo wnioski medycznych konsultacji,
które wasz lekarz jeszcze nie widział.

Krótki podręcznik o tym, jak przygotować się do odwiedzania w
POZ, można znaleźć za pomocą:

https://www.nfz-szczecin.pl/jqt1c_zanim_pojdziesz_do_lekarza_rodzinne_go.htm

5. **Чи завжди консультація лікаря POZ відбувається в поліклініці?**

Якщо стан здоров'я пацієнта не дозволяє відвідувати
поліклініку, візит може бути проведений за місцем
проживання після попередньої консультації з лікарем. Це
називається виклик лікаря додому (домовий візит). Якщо
ваша проблема не вимагає медичного огляду, ви можете
отримати допомогу по телефону. Це називається
телеконсультація (телепорада).

6. **Чи можу я відвідати заклад POZ зі своєю дитиною?**

Так. У вашому закладі POZ має бути педіатр або сімейний
лікар, який займається діагностикою та лікуванням
захворювань характерних для дитячого віку, а також
проводить щеплення та профілактичний огляд дитини
(баланс здоров'я дитини). Пам'ятайте, для того, щоб ваша

дитина могла скористатись послугами поліклініки POZ,
необхідно подати декларацію про вибір лікаря.

7. **Хто така медична сестра POZ?**

Медична сестра первинної ланки (POZ) – це медична сестра приймального відділення (pielęgniarka środowiskowa). Ви можете подати декларацію про вибір медичної сестри, звернувшись до закладу POZ або через ІКР.

Медсестра доглядає за пацієнтами в клініці, але також може здійснювати патронажні візити. До завдань медичної сестри приймального відділення входять:

- Подавання ліків.
- Проведення ін'єкцій.
- Зняття швів.
- Виконання інгаляції.
- Проведення медсестринського догляду та процедур.

8. **Хто така акушерка POZ?**

Акушерка первинної ланки (POZ) надає комплексну сестринську, акушерську та гінекологічну допомогу.

Акушерка POZ доглядає за жінками від 21-го тижня вагітності та новонародженими до 2 календарних місяців життя дитини. Акушерка POZ зобов'язана здійснити 4 - 6 патронажних відвідувань. Ви можете зустрітись з акушеркою в її кабінеті в поліклініці або вдома, залежно від ситуації.

До обов'язків акушерки входить:

- Догляд за вагітними жінками.
- Розпізнавання проблем зі здоров'ям.
- Планування та здійснення профілактичних послуг.
- Повчання вагітних жінок з підвищеним ризиком.
- Догляд за новонародженими.
- Обстеження дітей з урахуванням оцінки їх загального стану та адаптації дитини до навколишнього середовища.
- Допомога мамі зі встановленням контакту з дитиною і започаткуванням процесу годування грудьми.
- Пропагування поведінки батьків на користь здоров'я дитини.

9. В яких годинах працює заклад POZ?

До закладу POZ можна звернутися щодня з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00. Коли ваша поліклініка не працює, ви можете відвідати пункт цілодобової медичної допомоги.

III. Обліковий запис пацієнта

1. Що таке обліковий запис пацієнта (ІКР)?

Це додаток, який впорядковує різномірну медичну інформацію. Кожен, хто має номер PESEL, має ІКР, але цим обліковим записом можуть користуватися лише повнолітні.

Щоб використовувати ІКР, вам потрібно увійти на веб-сайт: <https://pacjent.gov.pl/>. Для цього необхідний електронний підпис, який можна створити через довірений профіль, тимчасовий довірений профіль або електронний паспорт. ІКР надає пацієнтам інформацію про їх попереднє, поточне чи планове лікування та дозволяє їм вирішувати низку питань без необхідності відвідування амбулаторії чи поліклініки. ІКР дає онлайн-доступ до повної історії хвороби та даних про проведені візити в поліклініці у лікаря, до інформації про форму допомоги, яку надано пацієнту, а також до квитанцій, котрі описують скільки NFZ заплатив за ці послуги. ІКР надає доступ до електронних рецептів, інформації про видані направлення та стан їх виконання, електронних лікарняних та медичних довідок, виданих у зв'язку з хворобою або виходом в декретну відпустку. ІКР також надає доступ до інформації про неповнолітніх дітей (якщо ви зареєстрували їх на своє страхування) та членів сімей, які надали нам доступ до інформації про стан свого здоров'я. Існує безкоштовний телефонний додаток "mojeikr".

2. Як увійти в ІКР і заповнити декларацію до POZ?

Крок 1

Перейдіть за посиланням <https://pacjent.gov.pl/>

Крок 2

У верхньому правому куті натисніть «Увійти».

Крок 3

Після входу в систему виберіть «Мій обліковий запис» і на панелі вкладок знайдіть «Ваша первинна медична допомога (POZ)». Натисніть «Заповнити декларацію».

Крок 4

Коли вам запропонують заповнити три електронні декларації, почніть з вибору лікаря PZO. У полі «Лікар» клацніть „Заповнити е-декларацію” (Важливо! Не забудьте вибрати лікаря, медичну сестру та акушерку (для жінок) для комплексної медичної допомоги)

Крок 5

Ваші дані введуться самостійно. Перевірте їх і в разі потреби доповніть.

Крок 6

Виберіть воєводство, місто, вулицю та заклад.

Крок 7

Після заповнення всіх полів клацніть праворуч «Підписати електронні декларації». Заява буде підписана через довірений профіль або кваліфікований підпис. Тепер ви можете користатися первинною медико-санітарною допомогою.

IV.

Рецепт на ліки

1.

Що таке рецепт?

Рецепт – це документ, який видає лікар, на підставі якого фармацевт може продати вам конкретний лікарський засіб.

2. На які ліки потрібен рецепт?

Рецепт зазвичай потрібен для придбання антибіотиків і ліків небезпечних для самостійного застосування, які виписуються лікарем-спеціалістом. Це, наприклад, снодійні, транквілізатори та протиепілептичні засоби.

3. На які ліки не потрібно мати рецепт?

Без рецепта можна придбати основні знеболюючі та жарознижуючі, деякі ліки від застуди та деякі мазі.

4. Як отримати рецепт?

Рецепт виписується лікарем, рідше медичною сестрою, під час особистого візиту або телеконсультації після проведення бесіди та запланованого лікування. Рецептом може бути 4-значний PIN-код або роздруківка зі штрих-кодом або QR-кодом. PIN-код надасть вам лікар, але також ви будете його мати у своєму ІКР, а якщо в ІКР виберете опцію повідомлення про рецепт, тоді ви отримаєте його SMS або електронною поштою.

5. Що робити, коли я отримав рецепт?

Реалізація рецепта відбувається в аптеці. Потрібно продиктувати свій номер PESEL і 4-значний PIN-код або показати штрих-код чи QR-код рецепта.

6. Як купити ліки зі знижкою?

Деякі ліки можна купити за пільгою завдяки відшкодуванню (рефундація). При виписуванні рецепта лікар визначає розмір знижки залежно від поставленого ним діагнозу (хронічні захворювання, деякі інфекції). Для пацієнтів віком від 75 років деякі ліки надаються безкоштовно.

7. Чи може закінчитися термін дії електронного рецепта

Так. Термін дії рецепта може залежати від типу ліків. Більшість рецептів дійсні протягом 30 днів.

Винятки:

- рецепт на антибіотик для перорального або ін'єкційного застосування діє 7 днів (у разі застосування антибіотиків в мазях, краплях - стандартно 30 днів).
- рецепт на 365 днів - ліки можна придбати за один раз або по кілька пакувань, але в одній аптеці. Якщо ви купуєте перше пакування пізніше, ніж через 30 днів, фармацевт зменшить кількість пакувань. За один раз ви можете придбати ліки на 180 днів терапії.

- рецепт на індивідуально виготовлені імунологічні препарати (наприклад, вакцини для десенсибілізації) та імпортовані з-за кордону дійсний протягом 120 днів. Це не стосується вакцин масового виробництва – наприклад, проти грипу – такий рецепт дійсний лише 30 днів.

V.

Лікарняні

1. Що таке електронний листок непрацездатності (eZLA)?

Лікар може виписати довідку про відсутність працівника у зв'язку з хворобою – т. зв. eZLA (неформально називається L4 від назви друку). Роботодавець завантажує електронне звільнення зі свого профілю на платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS). У рідкісних випадках, якщо роботодавець не користується з PUE ZUS, тоді лікар роздруковує довідку, і ви повинні надати роботодавцю її протягом 7 днів.

2. Як довго я можу перебувати на лікарняним?

Ви маєте право на 182 дні лікарняного, за винятком лікарняного під час вагітності або у зв'язку з туберкульозом – максимум 270 днів.

3. Що робити, якщо я досі залишаюся хворий, але не маю права на лікарняне?

Якщо ви вичерпали максимальну кількість днів лікарняного і ваше право на соціальну допомогу по хворобі закінчується, ви можете подати заявку до ZUS для отримання реабілітаційних послуг протягом 12 місяців.

4. Чи маю я право на лікарняне, якщо моя дитина чи інший член сім'ї хворіє?

Так. Лікар може виписати довідку про відсутність працівника у зв'язку з його хворобою або хворобою осіб, які перебувають під його опікою. eZLA, виписаний для батьків, які не можуть продовжувати працювати через хворобу дитини - це соціальна допомога по догляду за дитиною.

Щорічно можна використовувати:

- 60 днів догляду за хворою дитиною до 14 років
- 14 днів догляду за хворою дитиною 14-18 років чи інший член сім'ї.
- 30 днів у разі захворювання дітей-інвалідів 14-18 років

5. Чи заробітня плата на лікарняному однакова як під час працездатності?

Соціальна допомога по хворобі та по догляду за дитиною становить 80% від заробітної плати.

Він може становити 100% заробітної плати, якщо:

- це соціальна допомога по хворобі під час вагітності

- хвороба спричинена нещасним випадком під час роботи, по дорозі до роботи чи з роботи
- відсутність працівника на роботі є результатом участі в медичних процедурах, що надаються донорам клітин, тканин і органів

6. Чи роботодавець дізнається про мій діагноз?

Отримана роботодавцем довідка eZLA не містить діагнозу захворювання. Іноді звільнення включає в себе один із літерних кодів, що описують обставини захворювання, які впливають на розмір соціальної допомоги.

Код А - непрацездатність, що настала після перерви не більше ніж 60 днів, викликана тим самим захворюванням, що спричинило втрату працездатності до перерви.

Код В – непрацездатність під час вагітності

Код С – непрацездатність через зловживання алкоголем.

Працівник, який отримав листок непрацездатності за кодом С, не має права на заробітню плату чи соціальну допомогу протягом перших 5 днів з дня початку лікарняного.

Код D - непрацездатність через туберкульоз

Код Е - непрацездатність, спричинена інфекційною хворобою, інкубаційний період якої перевищує 14 днів, або іншим захворюванням, симптоми якого з'являються

через період більше ніж 14 днів від початку захворювання.

На письмове прохання пацієнта лікар може не вводити коди B і D.

7. Чи можу я отримати лікарняне з минулою датою або ж наперед?

Зазвичай лікар виписує лікарняне із зазначенням дати візиту. Лікарняне може бути виставлене з датою не раніше ніж за 3 дні до медичного огляду або телеконсультації. Виняток становить лікарняне від психіатра, яке може бути виписане ще раніше. Листок непрацездатності також може бути виписаний з датою наперед, тобто з наступного дня або, якщо наступні дні це державні святкові дні, з датою, коли ви повинні з'явитися на роботу.

8. Чи потрібно мені робити медичне обстеження, перш ніж повернутися на роботу?

Якщо ви хворіли більше 30 днів, вам потрібна довідка від лікаря POZ, що підтверджує вашу працездатність. Після отримання такої довідки роботодавець зобов'язаний направити вас на обстеження до лікаря медицини праці, щоб він вирішив, чи можете ви працювати на тій самій посаді. Вартість дослідження покриває роботодавець.

VI. Первинна медико-санітарна допомога – діти.

1. На яку медичну допомогу може розраховувати моя дитина в POZ?

Зазвичай роботу педіатра можна поділити на консультації хворих і здорових дітей. У рамках консультацій хворих дітей приймаються діти з симптомами інфекції. У години прийому здорових дітей проводяться щеплення, профілактичні огляди, а іноді й діагностика захворювань, які не викликані гострою інфекцією, наприклад, біль у животі, порушення харчування, аномальний ріст.

2. Що таке профілактичний огляд дитини (баланс здоров'я дитини)?

Профілактичний медичний огляд дитини слід проводити дітям: 1-4 тиждень життя, 2-6 місяць життя (в термінах вакцинації), місяць життя, 12 місяць життя, 2 роки, 4 роки, 5 років, річна обов'язкова дошкільна підготовка, з клас ЗОШ I ступеня, 1 клас ЗОШ II ступеня (7 клас), 1 клас ЗОШ III ступеня (10 клас) або професійно-технічного навчального закладу, останній клас ЗОШ III ступеня (12 клас) або професійно-технічного навчального закладу до 19 років.

Повноцінний баланс проводиться лікарем POZ дітям дошкільного віку. Діти шкільного віку приступають до

огляду в медичному пункті школи (зважування, вимірювання зросту, контроль артеріального тиску, огляд очей, огляд постави). Після такого первинного огляду шкільною медсестрою учні отримують довідку, з якою мають піти до закладу POZ.

Лікар POZ перевіряє, чи в зріст, вага, тиск, постава і гострота зору є в нормі, здійснює загальний медичний огляд та оцінює виконання профілактичних щеплень. При необхідності лікар першого контакту виписує направлення до інших спеціалістів або на лабораторні дослідження.

3. Як вакцинувати дитину?

Дітям, які перебувають у Польщі більше 3 місяців, слід продовжувати щеплення так, щоб налаштувати їх під календар вакцинації. Для цього необхідно записатися на прийом до педіатра або сімейного лікаря у вибраний вами заклад POZ (куди була подана декларація). При реєстрації слід зазначити, що візит відбуватиметься з метою вакцинавання. Для щеплення необхідно підготувати документи, в яких записані попередні вакцини (наприклад, медична книжка дитини).

4. Що таке календар вакцинації?

Календар вакцинації – це перелік обов'язкових щеплень із зазначенням віку, з якого вони мають бути зроблені.

Щороку він оновлюється Головним санітарним інспектором.

5. Як відбуватиметься вакцинування моєї дитини?

Лікар огляне дитину, щоб з'ясувати, чи є протипоказання до щеплення. Після того, як ваша дитина буде допущена до вакцинації, вас попросять підписати згоду.

Вакцинування проводить медична сестра. Після щеплення за хворим спостерігають не менше 15 хвилин. Якщо протягом цього часу тривожні симптоми не з'являються, можна залишити клініку.

6. Де можна придбати вакцину?

Обов'язкові щеплення є безкоштовними та доступні в закладі POZ. Щороку Міністерство охорони здоров'я визначає, які саме вакцини використовуватимуться згідно з календарем вакцинації.

Якщо ви хочете вибрати вакцину, відмінну від тієї, яку вибрало Міністерство, ви повинні за неї заплатити.

Вакцину можна придбати в деяких поліклініках (про це потрібно запитати при записі на візит) або заздалегідь попросити у лікаря рецепт і купити в аптеці. Вакцину, придбану поза поліклінікою, потрібно зберігати у вашому холодильнику на середній полиці, подалі від стінки холодильника, ні в якому разі не на дверцятах



холодильника. Її необхідно доставити в клініку в термоізоляційному пакеті.

7. Які щеплення являються обов'язковими для дітей в Польщі?

До польського календаря профілактичних щеплень включено наступні обов'язкові щеплення для дітей:

- після народження - проти туберкульозу та гепатиту В (БЦЖ; 1-а доза)
- в 2-му місяці життя - проти гепатиту В (2-а доза), проти дифтерії, правця, коклюшу (АКДП; 1-а доза) та проти гемофільної палички (1-а доза), проти ротавірусів (1-а доза)
- в 3-4-му місяці життя - проти дифтерії, правця, коклюшу (АКДП; 2-а доза), проти гемофільної палички (2-а доза) та проти поліомієліту (1-а доза), проти ротавірусів (2-а доза)
- в 5-6-му місяці життя - проти дифтерії, правця, коклюшу (АКДП; 3-я доза), проти гемофільної палички (3-я доза) та проти поліомієліту (2-а доза), проти ротавірусів (3-а доза)
- в 7-му місяці життя - проти гепатиту В (3-я доза)
- в 13-14-му місяці життя - проти кору, епідемічного паротиту, краснухи (КПК; 1-а доза)

- у віці 16-18 місяців - проти дифтерії, правця, коклюшу (АКДП; 4-та доза), проти гемофільної
- палички (4-та доза) та проти поліомієліту (3-та доза)
- у віці 6 років - проти дифтерії, правця, коклюшу (бустерна доза), проти поліомієліту (бустерна доза) та проти кору, паротиту, краснухи (КПК; 2-а доза)
- у віці 14 років - проти дифтерії, правця, коклюшу (бустерна доза)
- у віці 19 років - проти дифтерії та правця (бустерна доза)

Інформацію про графік вакцинації можна знайти на сайті:

<https://pacjent.gov.pl/pacient/profilaktichni-scheplennya-ditey>

VII. профілактичних щеплень

Організація

1. Де можна зробити щеплення?

Щеплення можна зробити в пунктах вакцинації, більшість з них знаходяться в закладі POZ.

2. Де можна зробити щеплення для моєї дитини?

Щеплення проводять у пунктах вакцинації. Під час пандемії COVID 19 було створено багато популяційних пунктів вакцинації, але більшість щеплень дітей проводяться в закладі POZ.

3. Які щеплення мені слід доповнити?

Планування щеплень здійснюється на підставі календаря вакцинавання, який оновлюється щороку. У випадку дітей, які перебувають у даній країні більше 3 місяців, щеплення повинні бути доповнені відповідно до календаря вакцинації даної країни. Деякі щеплення слід повторювати навіть дорослим пацієнтам (наприклад, проти дифтерії, правця та коклюшу, проти грипу), а їх графік можна узгодити з лікарем POZ.

VIII. Нічна та святкова медична допомога

1. Що таке нічна та святкова медична допомога?

Коли заклад POZ зачинений, обов'язок лікування беруть на себе нічні та святкові центри медичної допомоги (так звана цілодобова медична допомога). Якщо ви погано себе почуваєте і турбуєтесь, що наступного дня ваше здоров'я погіршиться, але загрози життю немає, зверніться до найближчого нічного та святкового закладу медичної допомоги. Якщо ви почуваєтеся себе погано, але ваш стан здоров'я стабільний, зачекайте до наступного дня і зверніться до лікаря.

2. В яких годинах працює заклад нічної та святкової медичної допомоги?

З 18:00 до 8:00 та цілодобово у святкові дні.

3. Де знайти адреси нічних та святкових закладів медичної допомоги?

Найближчий пункт нічної та святкової медичної допомоги можна знайти на сайті NFZ:

<https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/>.

4. З якими проблемами потрібно звертатися до нічних та святкових закладів медичної допомоги?

Ви можете скористатися допомогою лікаря такого пункту, якщо раптово захворіли і через тяжкість симптомів не зможете дочекатися, поки ваш заклад POZ відкриється. Це не стосується ситуації, коли ваше життя під загрозою, тому що тоді ви звертаєтеся до відділення екстреної допомоги (SOR).

IX. Відділення екстреної допомоги (SOR)

1. Що таке SOR?

SOR є частиною швидкої медичної допомоги. Метою даного відділу є розгляд станів, котрі загрожують життю

пацієнта. У SOR проводять первинну діагностику та стабілізують життєво важливі функції.

2. Як довго я буду чекати на лікаря в SOR?

Кожен пацієнт проходить процедуру медичного сортування (тріаж). Час очікування на допомогу залежить від категорії, яку вам призначать:

- червоний колір – негайне звернення до лікаря
- помаранчевий колір – час очікування на лікаря до 10 хвилин
- жовтий колір – час очікування на лікаря до 60 хвилин
- зелений колір – час очікування на лікаря до 120 хвилин
- синій колір означає час очікування на лікаря до 240 хвилин

На практиці в SOR найбільша група пацієнтів це люди із зелено-блакитних груп, яким насправді не варто було приходити до SOR. Через це час очікування може збільшитися до кількох додаткових годин.

3. В яких ситуаціях я можу звернутися до SOR?

Люди з раптовою загрозою здоров'ю та життю повинні негайно звернутися до SOR. До таких загроз відносять травми (наприклад, рани, розтягнення зв'язок, забої з підозрою на переломи), опіки, обмороження, алергії.

До SOR може вас довести служба швидкої допомоги з місця аварії або з дому у разі раптового погіршення стану здоров'я (наприклад, постійна задишка, біль у грудях, втрата свідомості).

4. В яких ситуаціях не можна звертатися до SOR?

Не варто приходити до SOR, щоб:

- отримати консультацію спеціаліста
- отримати рецепт на ліки
- отримати лікарняне
- змінити перев'язку
- отримати ін'єкцію
- зняти шви
- замінити катетер
- wymianę cewników
- виконати лабораторні аналізи
- у разі появи симптомів інфекції, що не загрожують життю людини (біль у горлі, нежить, кашель)

5. Які документи потрібно взяти з собою до SOR?

Вам потрібен номер PESEL та внутрішній паспорт або закордонний паспорт.

X. Служба швидкої допомоги

1. Що таке швидка медична допомога?

Служба швидкої допомоги надає допомогу в надзвичайних ситуаціях. У разі невідкладних ситуацій, що загрожують життю, телефонуйте за номером екстреної допомоги 999 або 112. На основі проведеної розмови диспетчер прийме рішення про необхідність виїзду бригади швидкої медичної допомоги.

2. В яких ситуаціях я маю викликати швидку допомогу?

Викличте швидку допомогу, якщо вам потрібна допомога у невідкладних ситуаціях, що загрожують життю, наприклад: біль у грудях, параліч, порушення мови, порушення свідомості, ДТП.

3. Як викликати швидку допомогу?

Викликати швидку допомогу зможеш за номерами 112 або 999.

4. Чи бригада швидкої допомоги відвезе мене у лікарню?

Рішення про необхідність везти вас у лікарню приймає лікар або фельдшер. Саме бригада екстреної медичної допомоги вирішує, до якого SOR ви поїдете – зазвичай це

найближчий SOR, де можна надати адекватну медичну допомогу.

XI. Амбулаторна спеціалізована медична допомога (AOS)

1. В яких ситуаціях мені варто записатися до спеціалізованої амбулаторії.

На візит до спеціалізованої клініки потрібно записатися, якщо дану проблему зі здоров'ям неможливо повністю діагностувати та вилікувати в POZ. У більшості випадків, щоб записатися на візит, потрібне направлення від вибраного вами лікаря POZ. На практиці саме він вирішує, в який момент вам звернутися у спеціалізовану клініку. У спеціалізованих центрах, які мають підписаний договір з NFZ, не визнають направлень, виданих лікарями з приватних клінік.

2. Як записатися до спеціалізованої амбулаторії?

До більшості клінік потрібне направлення, видане лікарем медичного страхування (лікар POZ або зі спеціалізованого центру). Ви отримуєте 4-значний код (PIN-код). Його може роздрукувати лікар, також ви можете отримати код за посередництвом SMS-повідомлення або електронної пошти (якщо ви піключили цю функцію в ІКР).

Ви можете записатися на візит по телефону або особисто, подаючи цей код і свій номер PESEL.

3. Чи потрібне мені направлення до кожної спеціалізованої амбулаторії?

Ні. Є винятки. Направлення до психіатра, акушера-гінеколога, онколога, венеролога і стоматолога не потрібно.

4. Як довго потрібно чекати на візит до лікаря-спеціаліста?

Час очікування на візит буває різний, іноді становить багато місяців. Якщо запропонований термін дуже віддалений, ви можете запитати про дату візиту в іншому закладі. У випадках, коли через стан здоров'я потрібна термінова консультація, лікар має дописати цю інформацію в направленні (допис „pilne”).

Інформацію про терміни візитів в спеціалізованих амбулаторіях, стаціонарах та терміни виконання хірургічних операцій можна знайти за адресою:

<https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/>

XII. стаціонарному лікуванні

Перебування на

1. Хто може направити мене на стаціонарне лікування?

До лікарні вас може направити лікар медичного страхування або лікар з приватного закладу.

2. Чи повинен я погоджуватися на запропоноване лікування в стаціонарі?

Ви маєте право відмовитися від госпіталізації. У цьому випадку лікар попросить вас надати письмову заяву про незгоду із запропонованим лікуванням.

3. Які права має пацієнт?

- право бути поінформованим про стан власного здоров'я. Інформацію про стан здоров'я пацієнта може отримати також уповноважена пацієнтом особа. Довіреність може бути письмовою або усною.
- право відмовитися від лікування
- право на медичну таємницю
- право на медичний висновок іншого лікаря
- право на доступ до своєї медичної документації. Вона також може бути доступна законному представнику або уповноваженій пацієнтом особі.
- право бути в супроводі близької людини
- право на душпастирську опіку або право на зустріч із священнослужителем тієї релігії, яку сповідує пацієнт. Ви повинні повідомити медперсонал про те, що хотіли б зустрітися зі священником вашої віри. Завдання медичного закладу — фактично реалізувати це право.

- право на лікування болю
- право на приватність та гідність
- право на подання скарги

4. Чи зобов'язана лікарня надати іноземному хворому перекладача?

Лікарня не має юридичного обов'язку надавати пацієнту перекладача. Лікарні часто за власною ініціативою створюють список працівників, які вільно володіють іноземними мовами. У разі виникнення проблем зі зрозумінням персоналу, будь ласка, зверніться до центрального офісу або воєводського відділення NFZ.

XIII. Вагітність та пологи

1. Хто може вести вагітність?

Згідно із законом вагітність може вести лікар або акушерка. На практиці це, як правило, лікар.

2. Якщо я вагітна, коли мені потрібно стати на облік і чи потрібне направлення?

Найкраще почати відвідувати обраного вами гінеколога-акушера до 10 тижня вагітності. Відвідування гінеколога не вимагає направлення.

3. На чому полягає медичний облік вагітної?

Лікар, який веде вагітність, призначатиме обстеження відповідно до стандартів, що діють у Польщі. На кожному етапі вагітності ви також можете вибрати координований догляд за вагітною (КОК) у пологовому відділенні лікарні. В такій ситуації жінка отримуватиме повноцінний догляд під час вагітності, пологів і через шість тижнів після народження дитини. За безпекою матері та дитини буде слідкувати команда у складі гінеколога, акушерки та лікарів пологового будинку.

4. Чи я маю право на УЗД під час вагітності?

Під час першого візиту проводиться УЗД, щоб підтвердити вагітність. Багато лікарів роблять УЗД під час кожного наступного візиту. Приблизно на 12 і 20 тижні вагітності проводиться ретельне ультразвукове дослідження, т. зв. генетичний УЗД скрінінг, яке дає можливість оцінити стан здоров'я дитини.

5. Що таке пренатальний скрінінг?

Пренатальний скрінінг (тестування) - це обстеження внутрішньоутробного розвитку плоду. Метою аналізів є виявлення будь-яких вроджених захворювань або генетичних дефектів. Тести проводять вагітним жінкам, які підходять хоча б під один з наведених нижче критеріїв:

- вагітна старше 35 років
- були генетичні дефекти під час попередньої вагітності
- вагітна жінка або батько дитини мають підтверджений генетичний дефект
- лікар виявив набагато більший ризик народження дитини з генетичним або мультифакторним захворюванням
- результат ультразвукового або біохімічного дослідження, проведеного під час вагітності, є відхиленням від норми

6. Чи я можу працювати під час вагітності?

Якщо ви відчуваєте себе добре, можете працювати під час вагітності, натомість ви не маєте можливості брати понаднормові години. Ви не мусите працювати вночі (нічна робота можлива лише за вашою згодою). Якщо ви переживаєте за дитину або стан здоров'я цього вимагає, потрібно взяти лікарняний. Кожне виставлене лікарняне під час вагітності дає право на виплату фінансової допомоги у розмірі 100% від заробітної плати.

7. Якщо я вагітна, чи може роботодавець через це мене звільнити?

Роботодавець не може звільнити або ж розірвати трудовий договір під час вагітності та декретної відпустки.

8. Чи мають вагітні особливі права?

Так. Вагітні жінки мають право на медичні та фармацевтичні послуги, які надаються в аптеках, позачергово. Послуга «позачергова» в спеціалізованих клініках означає візит у день запису або в інший день, але не пізніше 7 робочих днів від дати звернення.

Деякі ліки для вагітних є безкоштовними або покриваються пільгами, якщо лікар зробить відповідну відмітку в рецепті (літера B). До безкоштовних препаратів відносять: інсулін, лютеїн, левотироксин, метопролол.

9. Акушерка POZ.

Якщо ви вагітні, вам слід вибрати акушерку первинної ланки (POZ).

Вам потрібно буде надати контактні дані акушерки та лікаря POZ, яких ви вибрали, в лікарні після народження дитини. Акушерка первинної ланки опікується жінками з 21 тижня вагітності та новонародженими до 2 календарних місяців життя дитини. Акушерка POZ зобов'язана здійснити 4-6 патронажних відвідувань дитини. Перший візит відбувається не пізніше ніж через 48 годин після виписки матері та дитини з лікарні.

Батьки повинні вибрати акушерку до народження дитини та повідомити її про те, коли дитину випишуть додому.

10. Де жінки народжують дітей в Польщі?

Жінки в Польщі народжують у лікарнях, у пологовому відділенні. У Польщі немає пологових будинків окремих від лікарень. Пологи в домашніх умовах трапляються дуже рідко.

11. Що робити, якщо після повернення додому у мене виникли проблеми з грудним вигодовуванням?

Зверніться по допомогу до акушерки POZ. Також при пологових відділеннях є консультаційні пункти лактації, якими можна скористатися.

12. Які адміністративні справи я мушу вирішити після народження дитини?

Про народження дитини необхідно повідомити до органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) протягом 14 днів після народження. РАЦС видасть свідоцтво про народження, номер PESEL та зареєструє дитину. Після отримання номера PESEL дитину необхідно застрахувати на місці роботи одного з батьків або в ZUS. Потім виберіть для дитини лікаря POZ (педіатра або сімейного лікаря) та запишіться на візит, дата якого становитиме не пізніше

ніж 4 тижні після народження дитини (зазвичай через 2 тижні після народження).

13. Скільки триває декретна відпустка по вагітності і пологах?

Тривалість відпустки залежить від кількості народжених дітей:

20 тижнів - у разі народження однієї дитини одночасно,

31 тиждень - у разі народження двох дітей одночасно,

33 тижні - якщо в одні пологи народилося троє дітей,

Перед запланованою датою пологів працівниця може взяти до 6 тижнів декретної відпустки.

Якщо працівниця до пологів не користувалася декретною відпусткою, вона починає відпустку по вагітності та пологах з дня пологів.

14. Чи повинна я використати всю декретну відпустку по вагітності і пологах?

Після пологів мати повинна піти у відпустку на 14 тижнів.

Можна звільнитися з решти 6 тижнів відпустки та повернутися до роботи за умови, якщо частину відпустки по вагітності та пологах, що залишилася, використає другий піклувальник, який перервав свою працю, щоб забезпечити догляд за дитиною.

15. Що таке декретна відпустка по догляду за дитиною?

Відпустка по догляду за дитиною є продовженням відпустки по вагітності і пологах. Щоб скористатися відпусткою по догляду за дитиною, незалежно від того, хто з батьків дитини буде її оформляти, потрібне повне використання відпустки по вагітності та пологах та подання заяви роботодавцю протягом 21 дня з дня народження дитини.

Декретна відпустка по догляду за дитиною триває до 32 тижнів, якщо народилася одна дитина, і до 34 тижнів, якщо народилося більше однієї дитини.

Відпустка по догляду за дитиною може бути використана:

- повністю одним із працівників - батьків,
- одночасно обома працівниками - батьками, але тоді строки використання цієї відпустки працівницею і працівником-батьком сумуються і не можуть перевищувати 32 тижні для однієї дитини та 34 тижнів, якщо народилося більше однієї дитини
- по черзі обома батьками, які розділять між собою 32 тижні.

16. Чи зміниться моя зарплата під час декретної відпустки?

Ви маєте право на 80% вашої зарплати впродовж цілого року або 100% вашої зарплати під час відпустки по вагітності і пологах (20 тижнів) і 60% під час відпустки по догляду за дитиною (32 тижні).

17. Що таке декретна відпустка по вихованню дитини?

Відпустка по вихованню дитини надається працівнику, який працевлаштований не менше 6 місяців, для догляду за дитиною. Попередні працевлаштування також зараховуються до цього періоду роботи. Відпустку по вихованню дитини можуть взяти мати і батько, якщо вони обидва працевлаштовані.

Відпустка по вихованню дитини триває максимум 36 місяців. Її можна розділити навіть на 5 частин. Ви можете користуватися нею до кінця календарного року, в якому вашій дитині виповнюється 6 років. У разі надання відпустки по вихованню дитини-інваліда її можна використовувати до досягнення нею 18 років.

XIV. Стоматологічна допомога

1. Чи потрібно мати направлення до стоматолога?

Направлення до стоматолога не потрібно.

2. Чому поляки обирають приватну стоматологічну допомогу?

Поляки обирають приватну стоматологічну допомогу через суттєво обмежену пільгову систему державних закладів. «Білі» пломби відшкодовуються тільки в зубах від 1 до 3, у дорослих це композити хімічного затвердіння, у дітей – фотополімерні пломби. Відшкодування лікування кореневих каналів доступне лише для зубів від 1 до 3. Ортодонтичне лікування брекетами відшкодується лише до 12 років. Протезування також має істотні обмеження.

Перелік пільгових послуг можна знайти за посиланням:

<http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/leczenie-stomatologiczne/>

3. Що робити під час гострого зубного болю?

У разі раптового зубного болю вас зможуть прийняти в той же день в поліклініці, яка співпрацює з NFZ. Якщо у вас болить зуб, коли поліклініки закриті (вночі чи в неробочий день), зверніться до закладу, який надає невідкладну стоматологічну допомогу.

Перелік об'єктів можна знайти за адресою:

<https://pacjent.gov.pl/dorazna-pomoc-dentystyczna>

XV. Медична реабілітація

1. Які захворювання вимагають реабілітації?

Лікувальна реабілітація – це метод лікування багатьох захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, системи кровообігу та дихальної системи. Застосовується після операцій, у тому числі онкологічних.

2. Як виглядає реабілітаційне лікування?

Для реабілітації необхідне направлення від лікаря POZ.

Реабілітацію можете проходити:

- амбулаторно - для пацієнтів, які самостійно пересуваються
- вдома - для пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватися
- в реабілітаційному центрі або денному відділенні - для пацієнтів, які не потребують цілодобового медичного спостереження, а стан здоров'я яких не дозволяє проводити амбулаторну реабілітацію
- в стаціонарі – для пацієнтів, які у зв'язку з продовженням лікування потребують комплексних реабілітаційних послуг та цілодобового медичного та сестринського нагляду.

Більше інформації можна знайти за посиланням:

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/rehabilitacja-lecznicza>

3. Що таке соціальна допомога на реабілітацію?

Допомога на реабілітацію – це вид грошової допомоги для людей, які вже повністю використали свій лікарняний, а все ще непрацездатні. При цьому подальше лікування або реабілітація мають відновити працездатність хворого протягом 12 місяців. Допомогу на реабілітацію виплачує ZUS або роботодавець.

XVI. лікування

Санаторно-курортне

1. Що таке санаторно-курортне лікування?

Санаторно-курортне лікування є продовженням стаціонарного або амбулаторного лікування. Якщо для повноцінного одужання після хвороби, нещасного випадку або професійної хвороби вам потрібні певні процедури, які проводяться тільки в санаторно-курортних закладах, ви можете скористатися цим видом лікування. В санаторно-курортних закладах проводяться лікування мінеральними водами, грязелікування, кліматотерапія, водолікування, лікувальна фізична культура, кінезітерапія.

На санаторно-курортне лікування можуть бути направлені лише самостійні пацієнти, які достатньо підготовлені для поїздки до санаторію.

2. Чи потрібне направлення на санаторно-курортне лікування?

Направлення на санаторно-курортне лікування видається лікарем POZ, з урахуванням вашого стану здоров'я.

3. Що робити після отримання направлення?

Направлення має вислати лікар або Ви особисто до воєводського відділення NFZ. Направлення слід надіслати протягом 30 днів з дати видачі, інакше термін його дії закінчиться. В NFZ направлення перевіряє лікар, який оцінює доцільність, та вказує вид та місце санаторно-курортного лікування.

Якщо фахівець виявить протипоказання або вирішить, що до лікування немає показань – направлення буде анульовано. Його повернуть лікарю, який його видав, про що вам повідомлять письмово. Рішення є остаточне і оскарженню не підлягає.

Якщо термін лікування буде встановлено, воєводське відділення NFZ надасть вам підтверджене направлення не менше ніж за 14 днів до дати початку лікування.

4. Скільки триває санаторно-курортне лікування?

Для дорослої людини перебування в пансіонаті з лікуванням триває 21 день. Термін перебування дитини 27 днів. Проживання є безкоштовним.

Перебування в санаторії триває 21 день. Проживання дитини безкоштовне, дорослого - частково.

Перебування в пансіонаті з лікуванням під час санаторно-курортної реабілітації триває 28 днів, проживання безкоштовне.

Перебування в санаторії під час санаторно-курортної реабілітації триває 28 днів, частково оплачується.

Санаторно-курортне амбулаторне лікування дорослих і дітей триває від 6 до 18 днів.

Для отримання додаткової інформації відвідайте:

<https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1/>

XVII. Лікування залежності

1. Що робити, якщо я підозрюю у себе залежність?

Найкраще звернутися до лікаря POZ, який направить вас у відповідну клініку. Ви також можете звернутися відразу до психіатра, до якого не потрібне направлення. Якщо ви

залежні від алкоголю або психотропних речовин,
направлення до наркологічних відділень не потрібно.

2. Як виглядає лікування залежності?

Лікування залежностей є добровільним, за винятком судового рішення щодо лікування. Лікування може проходити в стаціонарі або амбулаторно.

Перелік центрів лікування залежностей можна знайти на сайті:
<https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/leczenie-uzaleznien/>

3. Де я можу знайти інформацію про лікування алкогольної залежності?

З переліком закладів та іншою важливою інформацією можна ознайомитися на сайті державного агентства з питань алкоголізму:
<https://www.parpa.pl/>

4. Що таке клуб АА?

Це анонімні клуби алкоголіків, центри самопомоги, створені людьми, які бажають кинути пити. Товариство утримується за рахунок власних внесків. Такі клуби розташовані в багатьох містах, також у менших містечках.

Список зустрічей АА можна знайти на сайті:
<https://spis.aa.org.pl/>

XVIII.

Онкологія

1. Що робити, якщо я підозрюю у себе онкологічне захворювання?

Найкраще звернутися до вашого лікаря POZ, який у разі потреби виконає відповідні аналізи або направить вас до онколога. Ви також можете звернутися відразу до онколога, до якого не потрібне направлення.

2. Що таке карта DiLO?

Дякуючи карті DiLO, пацієнту з підозрою пухлини запевняється прискорена діагностика і лікування пухлини. Карту DiLO може створити сімейний лікар, лікар зі спеціалізованого закладу або з лікарні.

3. Чи покриває страхування паліативну та хоспісну допомогу?

Якщо у вас невиліковна онкологічна хвороба і ви отримали направлення від лікаря, ви маєте право скористатися послугами в стаціонарному хоспісі або на відділення паліативної допомоги, в домашньому хоспісі або в клініці паліативної допомоги. Хоспіс спрямований на покращення якості життя невиліковно хворих пацієнтів, вони також розташовані в невеликих містечках. З переліком закладів можна ознайомитись на сайті обласного NFZ у вкладці «паліативна допомога».

XIX. Медичні вироби

1. Що таке медичні вироби?

Медичні вироби включають, наприклад, протези, ортопедичні апарати та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для інсулінових pomp, підгузники для дорослих, катетери, стомічні калоприймачі, слухові апарати, лінзи для окулярів, протипролежневі матраси.

2. Чи покриває страхування закупівлю медичних виробів?

Пацієнти мають право на відшкодування вартості медичних виробів. Відшкодування означає, що NFZ може частково або повністю покривати витрати на медичний виріб.

3. Як отримати дозвіл на закупівлю медичного виробу?

Дозвіл зазвичай виставляє лікар, але також медична сестра, акушерка, фізіотерапевт або інші уповноважені особи.

4. Де можна купити медичні вироби?

Придбати медичні вироби можна в пунктах, які мають договір з NFZ на постачання медичних виробів. Найчастіше це медичні магазини або аптеки.

XX.

Довіренний профіль

1.

Що таке довіренний профіль?

Довірений профіль – це підтверджений збір даних, які ідентифікують особу в адміністративних електронних сервісах. Ці дані включають ім'я, прізвище, дату народження та номер PESEL. Довірений профіль захищений таким чином, що ніхто, крім його власника, не може ним користуватися.

2.

Як створити довіренний профіль?

Ви створите довірений профіль на урядовому веб-сайті:

<https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany>.

Інструкцію щодо створення довіреного профілю можна знайти на урядовому сайті, на жаль, вона доступна лише польською мовою.

<https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/11841826/Instrukcja%20jak%20za%C5%82o%C5%BCy%C4%87%20Profil%20Zaufany.pdf/8d8c2a5d-a62a-4428-9d64-61c3e9917934/>

XXI.

Словник термінів

Badania prenatalne/Пренатальний скринінг –

обстеження, яке виконується з метою визначення ступня ризику розвитку вроджених та спадкових вад у плода.

Bilans zdrowia dziecka/Профілактичний огляд дитини

(баланс здоров'я дитини) – профілактичне обстеження дітей, котре проводиться в 2, 4, 6, 9, 16 і 18 років.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej/

Електронна платформа державних адміністративних послуг (ePUAP) – платформа, завдяки якій можна вирішити багато урядових питань не виходячи з дому. Електронні документи можна підписати за допомогою довіреного профілю.

Internetowe konto pacjenta/Обліковий запис пацієнта

(IKP) – інтернет-платформа, яка збирає інформацію про пацієнта в одному місці та дозволяє вирішити низку питань без необхідності відвідувати амбулаторію чи поліклініку.

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego/Карта

діагностики та онкологічного лікування (DiLO) – документ, який створюється сімейним лікарем або лікарем-спеціалістом та запевняє прискорену діагностику і лікування пухлини.

Leczenie odwykowe/Лікування залежності – форма

лікування спрямована на боротьбу з залежностями. Терапія проходить індивідуально, в групах або в спеціальних ізольованих центрах.

Leczenie rehabilitacyjne/Лікувальна реабілітація -

процедури, спрямовані на поліпшення фізичного та психічного функціонування пацієнта. Метод лікування багатьох

захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, системи кровообігу та дихальної системи.

Leczenie uzdrowiskowe/Санаторно-курортне лікування

– форма лікування в санаторно-курортних закладах, яка включає процедури, що покращують здоров'я, комплексну спеціалізовану допомогу та повчання про здоровий спосіб життя.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej/Лікар первинної ланки (POZ) – займається лікуванням дорослих (терапевт, тобто спеціаліст з внутрішніх хвороб, або сімейний лікар) та дітей (педіатр, тобто спеціаліст з дитячих хвороб, або сімейний лікар).

Narodowy Fundusz Zdrowia/Національний Фонд

Охорони Здоров'я (NFZ) – державна організація, яка займається фінансуванням медичних послуг загальної охорони здоров'я.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna/Нічна та святкова медична допомога – бере на себе обов'язок лікування, коли заклади POZ зачинені. Працює з 18:00 до 8:00 та цілодобово у святкові дні. Як синонім використовується термін „цілодобова допомога”.

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej/Медична сестра первинної ланки (POZ) – це медична сестра приймального відділення (pielęgniarka środowiskowa).

Pogotowie ratunkowe/Служба швидкої допомоги –

організаційна одиниця в системі охорони здоров'я, котра надає допомогу в надзвичайних ситуаціях. У разі невідкладних ситуацій, що загрожують життю, телефонуйте за номером екстреної допомоги 999 або 112.

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej/Акушерка

первинної ланки (POZ) - доглядає за жінками від 21-го тижня вагітності та новонародженими до 2 календарних місяців життя дитини.

Poradnia specjalistyczna/Спеціалізована амбулаторія –

місце, де послуги надають лікарі-спеціалісти. Щоб записатися на візит, потрібне направлення від вибраного вами лікаря POZ.

Podstawowa opieka zdrowotna/Первинна медико-

санітарна допомога (POZ) - частина системи охорони здоров'я, яка надає медичні послуги всім особам, які мають на це право і проживають/перебувають у Польщі.

Profil zaufany/Довіренний профіль -

підтверджений збір даних, які ідентифікують особу в адміністративних електронних сервісах.

Recepta roczna/Річний рецепт на ліки –

рецепт терміном дії 365 днів, на який лікар виписує більшу кількість упаковок ліків, та які пацієнт може поступово купувати в аптеці.

Rzecznik praw pacjenta/Омбудсмен/представник з прав

пацієнтів – посадова особа, яка розглядає заяви і скарги пацієнтів відносно медичних закладів і персоналу, а також

слідкує за дотриманням прав пацієнтів поліклініками, амбулаторіями, лікарнями та лікарями.

Szpitalny Oddział Ratunkowy/Відділення екстренної допомоги (SOR) – SOR є частиною швидкої медичної допомоги. Метою даного відділу є розгляд станів, котрі загрожують життю пацієнта.

Świadczenia rehabilitacyjne/Соціальна допомога на реабілітацію – це вид грошової допомоги для людей, які вже повністю використали свій лікарняний, а все ще непрацездатні.

Świadczenia zdrowotne/Медичні послуги - сдіяльність, спрямована на збереження, рятування, відновлення та зміцнення здоров'я, наприклад, відвідування лікаря, лабораторні дослідження, операція.

Świadczeniobiorca/Отримувач - особа, яка має право на медичні послуги, що фінансуються з державних коштів.

Świadczeniodawca/Надавач послуг – суб'єкт, який надає медичні послуги за договором з Національним Фондом Охорони Здоров'я, наприклад, заклад POZ.

Teleporada/Телеконсультація – телефонна консультація з лікарем.

Ubezpieczenie zdrowotne/Медичне страхування – дає право застрахованій особі користуватися медичними послугами, що фінансуються з державних коштів.

Urlop macierzyński/Декретна відпустка по вагітності і

пологах – обов’язкова відпустка для кожної жінки, яка працює за трудовим договором після народження дитини.

Urlop rodzicielski/Декретна відпустка по догляду за

дитиною - продовження відпустки по вагітності і пологах.

Нею може скористатися кожен з батьків. Щоб скористатися цією відпусткою, потрібне повне використання відпустки по вагітності та пологах.

Urlop wychowawczy/Декретна відпустка по вихованню

дитини - надається працівнику, який працевлаштований не менше 6 місяців, для догляду за дитиною.

Wyroby medyczne/Медичні вироби - група виробів

медичного призначення із суворо визначеними правилами проектування, продажу та використання.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Заклад соціального

страхування (ZUS) – державна організація, що виконує завдання у сфері соціального страхування в Польщі.

XXII. Бланки декларацій про вибір лікаря, медсестри та акушерки POZ

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

I. ДАНІ ОТРИМУВАЧА

1. Ім'я					2. Прізвище				
3. Дата народження			4. Номер PESEL, або серія та номер закордонного паспорту або внутрішнього паспорту						
____ - ____ - ____ день - місяць - рік									
5. Адреса місця проживання									
5A. Вулиця				5B. Номер будинку/квартири				5C. Індекс і місто	
6. Номер телефону (необов'язково)									
7. E-mail (необов'язково)									
8. Дані законного представника (в ситуації, якщо отримувач неповнолітній або повністю недієздатний¹)									
8A. Ім'я			8B. Прізвище				8C. Номер телефону (необов'язково)		
Адреса місця проживання									
8D. Вулиця			8E. Номер будинку/квартири				8F. Індекс і місто		
Адреса місця проживання									
8G. Вулиця			8H. Номер будинку/квартири				8I. Номер телефону (необов'язково)		
Адреса місця проживання									
8J. Вулиця			8K. Номер будинку/квартири				8L. Індекс і місто		
II. ДАНІ НАДАВАЧА									
9. На підставі ч. 1 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу», заявляю про вибір:									

9A. Назва (фірма) надавача	
9B. Адреса надавача	
10. В поточному календарному році я вибираю лікаря²⁾	
☐ перший раз або другий раз	☐ третій раз або більше ніж три рази ³⁾
11. В ситуації вибору надавача третій раз або більше ніж три рази в поточному календарному році потрібно зазначити, чи причиною вибору є:	
☐ обставина зазначена в ч. 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року „Про первинну медико-санітарну допомогу”: • зміна місця проживання • припинення надавання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної медичної допомоги у обраного надавача • досягнення отримувачем 18 років, коли лікар первинної ланки є лікарем 1-го або 2-го ступеня спеціалізації або спеціалістом з педіатрії • з інших причин з боку надавача (будь ласка, уточніть)	
.....	
☐ інша обставина	
III. ДАНІ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ (POZ)	
12. На підставі ч. 1 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу», заявляю про вибір:4)	
Ім'я і прізвище лікаря первинної ланки	
13. В поточному календарному році я вибираю лікаря:2)	
☐ перший раз або другий раз	☐ третій раз або більше ніж три рази ³⁾
14. В ситуації вибору лікаря третій раз або більше ніж три рази в поточному календарному році потрібно зазначити, чи причиною вибору є:	
☐ обставина зазначена в ч. 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року „Про первинну медико-санітарну допомогу”: • зміна місця проживання • припинення надавання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної медичної допомоги у обраного надавача • досягнення отримувачем 18 років, коли лікар первинної ланки є лікарем 1-го або 2-го ступеня спеціалізації або спеціалістом з педіатрії • з інших причин з боку надавача (будь ласка, уточніть)	
.....	
☐ інша обставина	
.....	
(дата)	(підпис отримувача або законного представника) ⁵⁾

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

I. ДАНІ ОТРИМУВАЧА

1. Ім'я					2. Прізвище				
3. Дата народження			4. Номер PESEL, або серія та номер закордонного паспорту або внутрішнього паспорту						
____ - ____ - ____ день - місяць - рік									
5. Адреса місця проживання									
5A. Вулиця				5B. Номер будинку/квартири			5C. Індекс і місто		
6. Номер телефону (необов'язково)									
7. E-mail (необов'язково)									
8. Дані законного представника (в ситуації, якщо отримувач неповнолітній або повністю недієздатний ¹)									
8A. Ім'я		8B. Прізвище				8C. Номер телефону (необов'язково)			
Адреса місця проживання									
8D. Вулиця		8E. Номер будинку/квартири			8F. Індекс і місто				
Адреса місця проживання									
8G. Вулиця		8H. Номер будинку/квартири			8I. Номер телефону (необов'язково)				
Адреса місця проживання									
8J. Вулиця		8K. Номер будинку/квартири			8L. Індекс і місто				

II. ДАНІ НАДАВАЧА

9. На підставі ч. 1 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу»,

заявляю про вибір:	
9A. Назва (фірма) надавача	
9B. Адреса надавача	
10. В поточному календарному році я вибираю лікаря²⁾	
☐ перший раз або другий раз	☐ третій раз або більше ніж три рази ³⁾
11. В ситуації вибору надавача третій раз або більше ніж три рази в поточному календарному році потрібно зазначити, чи причиною вибору є:	
☐ обставина зазначена в ч. 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року „Про первинну медико-санітарну допомогу”: • зміна місця проживання • припинення надавання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної медичної допомоги у обраного надавача • досягнення отримувачем 18 років, коли лікар первинної ланки є лікарем 1-го або 2-го ступеня спеціалізації або спеціалістом з педіатрії • з інших причин з боку надавача (будь ласка, уточніть)	
.....	
☐ інша обставина	
III. ДАНІ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ (POZ)	
12. На підставі ч. 1 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу», заявляю про вибір:4)	
Ім'я і прізвище медичної сестри первинної ланки	
13. В поточному календарному році я вибираю лікаря:2)	
☐ перший раз або другий раз	☐ третій раз або більше ніж три рази ³⁾
14. В ситуації вибору лікаря третій раз або більше ніж три рази в поточному календарному році потрібно зазначити, чи причиною вибору є:	
☐ обставина зазначена в ч. 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року „Про первинну медико-санітарну допомогу”: • зміна місця проживання • припинення надавання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної медичної допомоги у обраного надавача • досягнення отримувачем 18 років, коли лікар первинної ланки є лікарем 1-го або 2-го ступеня спеціалізації або спеціалістом з педіатрії • з інших причин з боку надавача (будь ласка, уточніть)	
.....	
☐ інша обставина	
.....	
(дата)	(підпис отримувача або законного представника) ⁵⁾

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА АКУШЕРКИ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

I. ДАНІ ОТРИМУВАЧА

1. Ім'я					2. Прізвище				
3. Дата народження			4. Номер PESEL, або серія та номер закордонного паспорту або внутрішнього паспорту						
_ - _ - _ день - місяць - рік									
5. Адреса місця проживання									
5A. Вулиця				5B. Номер будинку/квартири				5C. Індекс і місто	
6. Номер телефону (необов'язково)									
7. E-mail (необов'язково)									
8. Дані законного представника (в ситуації, якщо отримувач неповнолітній або повністю недієздатний ¹)									
8A. Ім'я			8B. Прізвище				8C. Номер телефону (необов'язково)		
Адреса місця проживання									
8D. Вулиця			8E. Номер будинку/квартири				8F. Індекс і місто		
Адреса місця проживання									
8G. Вулиця			8H. Номер будинку/квартири				8I. Номер телефону (необов'язково)		
Адреса місця проживання									
8J. Вулиця			8K. Номер будинку/квартири				8L. Індекс і місто		
II. ДАНІ НАДАВАЧА									
9. На підставі ч. 1 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу», заявляю про вибір:									

9A. Назва (фірма) надавача	
9B. Адреса надавача	
10. В поточному календарному році я вибираю лікаря²⁾	
☐ перший раз або другий раз	☐ третій раз або більше ніж три рази ³⁾
11. В ситуації вибору надавача третій раз або більше ніж три рази в поточному календарному році потрібно зазначити, чи причиною вибору є:	
☐ обставина зазначена в ч. 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року „Про первинну медико-санітарну допомогу”: • зміна місця проживання • припинення надавання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної медичної допомоги у обраного надавача • досягнення отримувачем 18 років, коли лікар первинної ланки є лікарем 1-го або 2-го ступеня спеціалізації або спеціалістом з педіатрії • з інших причин з боку надавача (будь ласка, уточніть)	
.....	
☐ інша обставина	
III. ДАНІ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ (POZ)	
12. На підставі ч. 1 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу», заявляю про вибір:4)	
Ім'я і прізвище акушерки первинної ланки	
13. В поточному календарному році я вибираю лікаря:2)	
☐ перший раз або другий раз	☐ третій раз або більше ніж три рази3)
14. В ситуації вибору лікаря третій раз або більше ніж три рази в поточному календарному році потрібно зазначити, чи причиною вибору є:	
☐ обставина зазначена в ч. 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року „Про первинну медико-санітарну допомогу”: • зміна місця проживання • припинення надавання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної медичної допомоги у обраного надавача • досягнення отримувачем 18 років, коли лікар первинної ланки є лікарем 1-го або 2-го ступеня спеціалізації або спеціалістом з педіатрії • з інших причин з боку надавача (будь ласка, уточніть)	
.....	
☐ інша обставина	
..... (дата)	 (підпис отримувача або законного представника) ⁵⁾

ПОЯСНЕННЯ:

- 1)
Декларації, заповнені законними представниками від імені неповнолітніх після досягнення ними повноліття, залишаються дійсними до обрання іншого лікаря первинної ланки, а якщо лікарем первинної ланки є лікар зі спеціалізацією 1-го або 2-го ступеня або спеціалістом з педіатрії, декларації залишаються дійсними відносно вибору надавача до обрання іншого лікаря первинної ланки або обрання нового надавача (ч. 3 ст. 6 та ч. 7 ст. 10 Закону від 27 жовтня 2017 року про „Первинну медико-санітарну допомогу”).
- 2)
Отримувач має право безкоштовно вибрати надавача або лікаря первинної ланки не більше двох разів на календарний рік, а за кожний наступний вибір потрібно сплатити 80 злотих. Отримувач не сплачує у разі зміни свого місця проживання або у разі припинення надання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної ланки у обраного надавача медичних послуг, або коли отримувач, чий лікар первинної медичної допомоги є лікарем зі спеціалізацією 1-го або 2-го ступеня або спеціалістом в галузі педіатрії, досягнув 18-річного віку, або з інших причин зі сторони надавача (ч. 4 і 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу»)
- 3)
У разі здійснення третього та наступного вибору, будь ласка, надайте інформацію, чи є причиною відбору обставина, зазначена у ч. 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року про „Первинну медико-санітарну допомогу”, тобто зміна свого місця проживання або у разі припинення надання медичних послуг обраним надавачем, лікарем первинної ланки у обраного надавача медичних послуг, або коли отримувач, чий лікар первинної медичної допомоги є лікарем зі спеціалізацією 1-го або 2-го ступеня або спеціалістом в галузі педіатрії, досягнув 18-річного віку, або з інших причин зі сторони надавача (ч. 4 і 5 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу»)
- 4)
Одержувач може обрати лікаря первинної ланки, медичну сестру первинної ланки або акушерку первинної ланки у того ж самого надавача, у різних надавачів або ж будучи надавачами (ч. 3 ст. 9 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу»)
- 5)
Заповнити у разі подання декларації в паперовій або електронній формі, зазначеної у п. 1 або 2, ч. 1, ст. 10 Закону від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медико-санітарну допомогу”.

XXIII. Умови проведення патронажів та планових обстежень дитини, в тому числі скрінінгові дослідження.

No.	ВІК АБО ЕТАП ОСВІТИ	ПАТРОНАЖ І ПЛАНОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДИТИНИ, В ТОМУ ЧИСЛІ СКРІНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ*
1	1-4 тиждень життя	Патронаж лікаря первинної ланки, в який входить анамнез і фізикальне обстеження, включаючи фізичний розвиток, вимірювання і моніторинг окружності голови, оцінку жовтяниці, базову неврологічну оцінку та фізикальне обстеження для виявлення вродженої дисплазії кульшового суглоба.
2	2-6 місяць життя (в термінах вакцинації)	• Анамнез і фізикальне обстеження, включаючи фізичний розвиток (виміри: маса і довжина тіла, окружність голови та грудної клітки), перенесені захворювання та профілактика рахіту. • Оцінка розмірів переднього тім'ячка. • Оцінка неврологічного стану. • Визначення зубного віку. • У хлопчиків огляд наявності яєчок в мошонці. • Проведення тесту на розвиток слухових реакцій - у разі неправильного результату тесту або встановлення приналежності до групи ризику пошкодження слуху, направлення до спеціаліста аудіологічної чи фоніатричної діагностики. • Оцінка наявності факторів ризику пошкодження слуху. • Фізикальне обстеження для виявлення вродженої дисплазії кульшового суглоба.
3	• 9 місяць життя	• Анамнез і фізикальне обстеження, включаючи фізичний розвиток (виміри: маса і довжина тіла, окружність голови та грудної клітки) та психомоторного розвитку. • Оцінка виконання профілактичних щеплень відповідно до календаря щеплень. • Проведення тесту на розвиток слухових реакцій.
4	12 місяць життя	• Анамнез і фізикальне обстеження, включаючи фізичний розвиток (виміри: маса і довжина тіла, окружність голови та грудної клітки) та

		психомоторного розвитку. • Оцінка виконання профілактичних щеплень відповідно до календаря щеплень. • Проведення тесту на розвиток слухових реакцій. • Оцінка наявності нових факторів ризику пошкодження слуху. • Вимірювання артеріального тиску.
5	2 роки	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • анамнез і фізикальне обстеження, включаючи фізичний розвиток (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ), а також психомоторний розвиток і перенесені хвороби; • оцінка виконання профілактичних щеплень відповідно до календаря щеплень; • оцінка наявності факторів ризику пошкодження слуху; • проведення тесту на розвиток слухових реакцій та оцінка мовленнєвого розвитку; • проба Гіршберга для визначення кута косоокості; • вимірювання артеріального тиску.
6	4 роки	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • оцінка наявності факторів ризику пошкодження слуху; • анамнез і фізикальне обстеження, включаючи фізичний розвиток (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ), а також психомоторний та соціальний розвиток; • проведення тесту на розвиток слухових реакцій та оцінка мовленнєвого розвитку; • оцінка гігієни ротової порожнини.
7	5 років**	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • анамнез і фізикальне обстеження, включаючи фізичний розвиток (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ), а також психомоторний та соціальний розвиток; • вимірювання артеріального тиску.
8	Річна обов'язкова дошкільна підготовка *** (****)	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • анамнез: • анамнез від законних представників або законних

		чи фактичних опікунів та дитини, з урахуванням факторів ризику для здоров'я та здорової поведінки, • аналіз інформації, що міститься в документації профілактичного огляду, • аналіз інших наявних індивідуальних медичних документації; • фізикальне обстеження, включаючи оцінку: • фізичного розвитку (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ), • психомоторного розвитку, • мовлення, • латералізації, • опорно-рухового апарату, • ротової порожнини, • у хлопчиків - наявності яєчок в мошонці та дефектів сечостатевої системи; • виявлення порушень опорно-рухового апарату, в тому числі бічного викривлення хребта, статичних деформацій нижніх кінцівок; • виявлення косоокості (Cover test, тест Гіршберга); • виявлення порушень гостроти зору; • оцінка виконання профілактичних щеплень відповідно до календаря щеплень; • проведення тесту на розвиток слухових реакцій та оцінка мовленнєвого розвитку; • оцінка наявності факторів ризику пошкодження слуху; • вимірювання артеріального тиску; • за потреби спеціалізований медичний огляд; • висновок дослідження із зазначенням шкільної зрілості та кваліфікації до групи з фізичного виховання (включаючи уроки плавання) та можливих проблем зі здоров'ям; • рекомендації пов'язані зі здоровим способом життя.
9	3 клас ЗОШ I ступеня****	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • анамнез: • анамнез від законних представників або законних чи фактичних опікунів та дитини, з урахуванням факторів ризику для здоров'я та здорової поведінки, • аналіз інформації, що міститься в документації

		профілактичного огляду від шкільної медсестри, з урахуванням результатів скринінгових тестів, а також від класного керівника, • аналіз інших наявних індивідуальних медичних документації; • фізикальне обстеження, включаючи оцінку: • фізичного розвитку (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ), • психомоторного розвитку, • опорно-рухового апарату, • сечостатевої системи, • статевого дозрівання відповідно до шкали Таннера • щитовидної залози, • ротової порожнини; • виявлення порушень опорно-рухового апарату, в тому числі бічного викривлення хребта; • виявлення порушень гостроти зору та кольорового зору; • вимірювання артеріального тиску; • за потреби спеціалізований медичний огляд; • висновок дослідження із зазначенням рівня та темпу фізичного, психосоціального розвитку (орієнтовна оцінка), шкільної адаптації, кваліфікації до групи з фізичного виховання і шкільного спорту та можливих проблеми зі здоров'ям; • рекомендації пов'язані зі здоровим способом життя.
10	1 клас ЗОШ II ступеня (7 клас)****	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • анамнез: • анамнез від законних представників або законних чи фактичних опікунів та дитини, з урахуванням факторів ризику для здоров'я та здорової поведінки, • аналіз інформації, що міститься в документації профілактичного огляду від шкільної медсестри, з урахуванням результатів скринінгових тестів, а також від класного керівника, • аналіз інших наявних індивідуальних медичних документації; • фізикальне обстеження, включаючи оцінку: • фізичного розвитку (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ),

		• психомоторного розвитку, • опорно-рухового апарату, • щитовидної залози, • статевого дозрівання, • сечостатевої системи, • ротової порожнини, • шкіри; • виявлення порушень опорно-рухового апарату, в тому числі бічного викривлення хребта і кіфозу; • виявлення порушень гостроти зору; • виявлення порушень слуху (тест слухової орієнтації шепотом); • вимірювання артеріального тиску; • за потреби спеціалізований медичний огляд; • висновок дослідження із зазначенням рівня та темпу зростання та статевого дозрівання, психосоціального розвитку (орієнтовна оцінка), шкільної адаптації, кваліфікації до групи з фізичного виховання і шкільного спорту та можливих проблеми зі здоров'ям; • рекомендації пов'язані зі здоровим способом життя.
11	1 клас ЗОШ III ступеня (10 клас) або професійно-технічного навчального закладу ****	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • анамнез: • анамнез від учня та законних представників або законних чи фактичних опікунів, з урахуванням факторів ризику для здоров'я та здорової поведінки, • аналіз інформації, що міститься в документації профілактичного огляду від шкільної медсестри, з урахуванням результатів скринінгових тестів, а також від класного керівника, • аналіз інших наявних індивідуальних медичних документації; • фізикальне обстеження, включаючи оцінку: • фізичного розвитку (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ), • психомоторного розвитку, • статевого дозрівання, • опорно-рухового апарату, • щитовидної залози,

		• ротової порожнини, • шкіри; • виявлення порушень опорно-рухового апарату, в тому числі бічного викривлення хребта і кіфозу; • виявлення порушень гостроти зору; • вимірювання артеріального тиску; • за потреби спеціалізований медичний огляд; • висновок дослідження із зазначенням рівня та темпу зростання та статевого дозрівання, психосоціального розвитку (орієнтовна оцінка), шкільної адаптації, кваліфікації до групи з фізичного виховання і шкільного спорту та можливих проблеми зі здоров'ям; • рекомендації пов'язані зі здоровим способом життя та з точки зору майбутнього вибору подальшої освіти чи роботи.
12	Останній клас ЗОШ III ступеня (12 клас) або професійно-технічного навчального закладу до 19 років	Профілактичний медичний огляд (баланс здоров'я дитини) включає: • анамнез: • анамнез від учня, з ураженням факторів ризику для здоров'я та здорової поведінки, • аналіз інформації, що міститься в документації профілактичного огляду від шкільної медсестри, з урахуванням результатів скринінгових тестів, а також від класного керівника, • аналіз інших наявних індивідуальних медичних документації; • фізикальне обстеження, включаючи оцінку: • фізичного розвитку (виміри: маса і довжина тіла), в тому числі визначення індексу маси тіла (ІМТ), • психомоторного розвитку, • сечостатевої системи та статевого дозрівання, • опорно-рухового апарату, • щитовидної залози, • ротової порожнини, • шкіри; • виявлення порушень гостроти зору; • вимірювання артеріального тиску; • за потреби спеціалізований медичний огляд; • висновок дослідження із зазначенням можливої проблеми зі здоров'ям, а також пропозиції та поради щодо подальшого навчання та вибору професії,

		майбутнього батьківства, здорового способу життя, у тому числі фізичної активності.
--	--	---

- * Обстеження у дітей до 16 років проводяться в присутності законних або фактичних опікунів.
- ** У 5-річної дитини, яка не проходить обов'язкову річну дошкільну підготовку.
- *** Якщо огляд не проведено вчасно, в 1 класі початкової школи проводяться скринінгові тести.
- **** Якщо немає переходу до наступного класу, скринінгові тести повторно не проводяться.